

Procedimento Operacional Padrão – POP						
Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
06/12/2022	08/12/2022	08/12/2024	08/12/2024	Nº 01	22	1 de 8
Nome do Procedimento: Prescrição insumos para tratamento de feridas na Atenção Primária						
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Políticas de Saúde						
Gerência: Gerências de Distritos Sanitários						
Serviço executante: Todas as Unidades da Atenção Primária à Saúde						
Profissionais Executantes: Enfermeiros da APS						
Objetivo: Orientar Enfermeiros sobre a indicação e prescrição de curativos no Município de Joinville						
Recursos necessários: Computador com acesso à internet, acesso ao Prontuário Eletrônico no Sistema Integrado de Gestão (SIG–SaúdeTech)						

CONCEITO

Feridas são definidas como a perda da solução de continuidade do tegumento, representadas não apenas pela ruptura da pele e do tecido celular subcutâneo, mas também, em alguns casos músculos, tendões e ossos. Podem ser classificadas quanto à etiologia, complexidade e tempo de evolução (SMANIOTTO, 2010).

O tratamento de ferida é dinâmico e deve acompanhar a evolução científico-tecnológica. Por isso, as coberturas selecionadas complementam o tratamento de forma a diminuir o tempo de cicatrização, elevar a qualidade de vida e reduzir custos para o município (Protocolo de Assistência no Tratamento de Feridas, 2015).

Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, manifesta no seu Art. 11, § I que, O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: § I – privativamente: alínea “i” consulta de enfermagem e “j” prescrição da assistência de enfermagem, entre outros.

Assim salienta-se que o(a) enfermeiro(a) possui autonomia para realizar procedimentos de prevenção, promoção, proteção à saúde, realização de prescrição de enfermagem, ações de recuperação e reabilitação.

Ressalta-se ainda que, na assistência ao tratamento de feridas, compete ao enfermeiro a prescrição e a utilização de coberturas primárias e secundárias que se enquadrem na descrição da RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 (Anvisa, 2001) de produtos para a saúde (ou correlatos).

Na assistência ao tratamento de feridas, a primeira avaliação e as condutas iniciais devem ser realizadas pelo(a) enfermeiro(a). A partir disso, a equipe de enfermagem realizará o cuidado compartilhado, cabendo sempre ao enfermeiro(a) orientar e supervisionar esta equipe, assim como realizar a supervisão periódica em sala de curativos.

No registro em prontuário eletrônico é importante conter a Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP), lembrando que o Sistema aceita até dois registros de CIAP no mesmo atendimento, caso o usuário apresente outros sinais/sintomas avaliados, verificar a lista do CIAP e utilizar o código mais adequado.

Abaixo códigos de CIAP relacionados à assistência ao tratamento de feridas:

- ✓ S97 – Úlcera crônica de pele
- ✓ S19 – Outra lesão cutânea
- ✓ S14 – Queimadura/Escaldão

Importante: Toda assistência de enfermagem deve ser registrada em prontuário eletrônico.

A assistência ao tratamento de feridas sugere abordagem multiprofissional, devendo ser compartilhada com a Equipe Multiprofissional, levando em consideração suas particularidades e as atribuições de cada profissional.

DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE CURATIVOS

Curativo Convencional

É aquele realizado com Solução Fisiológica a 0,9% e gaze estéril pela equipe de enfermagem, conforme o descritivo:

- ✓ Composição: cloreto de sódio a 0,9%;
- ✓ **Ação:** mantém a umidade da ferida, favorece o desbridamento autolítico e a formação de tecido de granulação;
- ✓ **Indicação:** manutenção da ferida úmida;
- ✓ **Contra-indicações:** não há;
- ✓ **Aplicação e troca:** umedecer as gazes de contato o suficiente para manter o leito da ferida úmida até a próxima troca, ocluir com gazes estéril e seca. As trocas deverão ser feitas conforme a saturação das gazes e a umidade da ferida ou no máximo a cada 24 horas;
- ✓ O prazo de validade do frasco de SF 0,9% após aberto é de 24 horas, identificar o frasco com a data e horário de abertura na sala de curativo, não utilizar após esse prazo, deve ser descartado.
- ✓ Para prescrição de SF 0,9% consultar Nota Técnica nº 01/2022 - SES/ENF – Prescrição de insumos de uso domiciliar pelo profissional enfermeiro (a) disponibilizada no processo SEI 0014408526 anexo 0014411473.

Atenção! A irrigação deve ser realizada com solução fisiológica 0,9%, morna (para não retardar o processo de cicatrização), utilizando seringa de 20ml e agulha 40x12 (a pressão exercida no leito da lesão não deve ultrapassar 15 PSI – Libra por polegada quadrada, a fim de preservar os neotécidos formados) ou frasco de SF 0,9% perfurado com agulha 40x12.

Usuários totalmente acamados em domicílio/Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), é possível entregar kit simples de curativo convencional para familiar e/ou cuidador, desde que, tenham recebido orientação da confecção do curativo pela equipe de enfermagem, deverá ser realizado o acompanhamento e avaliação da ferida como também, a evolução em prontuário eletrônico de toda assistência realizada.

Quadro 01: Kits simples de Curativos Convencionais por semana

Quantidade padronizada de material para curativo simples, para 7 dias			
*Material	Kit Pequeno	Kit Médio	Kit Grande
Solução fisiológica 100 ou 250 ml	3 unidades	7 unidades	7 unidades
Gaze estéril	3 pacotes com 10 gazes	7 pacotes com 10 gazes	14 pacotes com 10 gazes
Agulha 40 x 12	3 (um para cada soro)	7 (um para cada soro)	7 (um para cada soro)
Atadura se necessário	7 unidades	7 unidades	7 unidades
Chumaço estéril	0	0	7 unidades

Elaborado pela Comissão de Enfermeiros(as) da APS (SES/Joinville, 2021).

*Materiais disponíveis para pedido mensal da Unidade de Saúde ao Came.

Código de procedimento – **Curativo Simples 03.01.10.028-4**: Consiste em curativos feitos em feridas simples, que são pequenos ferimentos nos quais não ocorre perda de tecidos nem contaminação grosseira. Aqui está incluída a maioria das feridas produzidas por acidentes domésticos, lacerações discretas, feridas cortantes pequenas/superficiais ou feridas cirúrgicas simples no acompanhamento pós-operatório. Somente utilizar este Código de procedimento se for efetivamente realizada a troca de curativo pelo profissional.

A Equipe de Enfermagem irá proceder a entrega dos materiais para curativos ao usuário ou responsável na sala de curativos e registrar no Prontuário Eletrônico quais materiais foram entregues e quantitativos, utilizando o código de procedimento: **99980152 – PM Entrega de materiais para uso domiciliar**.

Curativos Especiais

São indicadas para feridas crônicas que não apresentam respostas ao curativo convencional, é indicada mediante avaliação do(a) enfermeiro(a) e conforme critérios de inclusão no programa.

CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA AVALIAÇÃO DA FERIDA

Considerando o Protocolo de Assistência ao Tratamento de Feridas (2015) do Município, a primeira avaliação está descrita como **ATRIBUIÇÃO DO(A) ENFERMEIRO(A)** por meio de uma consulta de enfermagem, durante esta avaliação o(a) enfermeiro(a) observará o usuário e sua lesão.

Nesta consulta de enfermagem deve-se avaliar, mensurar e classificar a ferida e somente após propor o curativo adequado:

- ✓ **Entrevista e exame físico:** (histórico de saúde, medicações, nível de escolaridade, estilo de vida, hábitos alimentares, estado nutricional, higiene pessoal, suporte social e familiar etc);
- ✓ **Avaliar características da(s) ferida(s):** localização, identificação e mensuração de túneis/solapamentos, grau de lesão tecidual, aspecto e quantidade de exsudato, odor, dor, observação do leito da ferida, área perilesional e presença de infecção. Sempre que o usuário apresentar mais de 1 (uma) lesão não é necessário encaminhar solicitação e fotos de todas as lesões, porém deve incluir no programa as 3 maiores lesões e mais complexas;
- ✓ Identificar a causa da lesão, em caso de dúvida, discutir com médico da Equipe o encaminhamento para a especialidade;
- ✓ Definir o tipo de curativo: convencional ou cobertura especial.

SEI Programa Municipal de Curativos Especiais: SEI 20.0.143766-2, neste SEI estão: Fluxograma, Memorandos, Termo Compromisso, Autorização, Termo de Autorização de Divulgação da Imagem da Lesão.

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO AO PROGRAMA DE CURATIVO ESPECIAL

- ✓ Pessoas com lesões crônicas;
- ✓ Recidivadas e/ou complexas, que aderem ao tratamento atendendo a periodicidade de troca das coberturas;
- ✓ Retorno à Unidade de Saúde quantas vezes for solicitado;
- ✓ Manutenção dos padrões mínimos de higiene e de limpeza local e, principalmente, que assume as mudanças necessárias no estilo de vida.

CADASTRO DE NOVO USUÁRIO NO PROGRAMA DE CURATIVO ESPECIAL DE JOINVILLE

- ✓ Após a avaliação inicial, se o usuário atende os critérios de inclusão ao Programa, o(a) Enfermeiro(a) aplica o Termo de Compromisso no Tratamento de feridas (SEI 9657404/2021). *O

Termo de Compromisso no Tratamento de feridas também está disponível no Sistema SIG-SaúdeTech, no Perfil de Enfermeiro em → Prescrições Livres → Tipo TERMOS → Modelos → TERMO → Termo de Compromisso Tratamento de feridas. Neste caso, o usuário fica ciente de suas responsabilidades com o programa e assume o compromisso de continuidade no tratamento junto à Unidade de Saúde, por meio do preenchimento do Termo de Compromisso. Considerando que o Protocolo de Assistência ao Tratamento de Feridas possui o Termo de Autorização de Divulgação da Imagem da Lesão, somente divulgar imagem da ferida, após autorização no termo em questão, para respaldo da Equipe de Saúde. A foto não é obrigatória, porém o envio da imagem da lesão, auxilia no acompanhamento da evolução deste tratamento e também na indicação de troca de cobertura. Quando mudar características da lesão, enviar nova foto somente se autorizado pelo usuário/responsável;

- ✓ A solicitação da cobertura especial deverá ser realizada obrigatoriamente pelo(a) enfermeiro(a) e somente por meio do link: bit.ly/curativosjille (Cadastrar novo paciente no programa de curativos);
- ✓ Anexar obrigatoriamente o *Termo de Comprometimento no Tratamento* em conformidade com o Memorando SEI nº 9657404/2021;
- ✓ Realizar a prescrição das coberturas especiais conforme materiais padronizados no município e conforme disponibilidade no CAME:
 - Ácido Graxos Essenciais (AGE);
 - Hidrogel 15 gramas;
 - Gel Hidratante com Alginato de Cálcio 85 gramas;
 - Curativo de Alginato de Cálcio 10 X 10 cm;
 - Alginato de Cálcio 15 X 15 cm;
 - Curativo de Alta Absorção com Prata;
 - Curativo de Alta Absorção com Prata 100% Hidrofibra;
 - Gaze Antiaderente 7,6 X 7,6 cm;
 - Curativo Filme Transparente 10 cm X 10 cm;
 - Hidrocolóide sem borda 10 X10 cm;
 - Hidrocolóide sem borda 20 X20 cm;
 - Bota de Unna.
- ✓ O(a) enfermeiro(a) obrigatoriamente realizará a requisição de cobertura especial com previsão de 30 dias. Caso seja necessária quantidade maior ao número parametrizado no link, o(a) enfermeiro(a) deverá solicitar o material excedente oficialmente por meio do e-mail do Programa de Curativos Especiais: curativosjoinville@gmail.com;
- ✓ Determinar o período de troca do curativo que deverá ser realizado na sala de curativos na UBSF ou em visita domiciliar;
- ✓ A cobertura especial não deve ser entregue diretamente ao usuário/familiar/cuidador, com exceção ao familiar e/ou cuidador de usuário totalmente acamado em domicílio/Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) desde que, tenham recebido orientação da confecção do curativo com a cobertura especial pelo(a) Enfermeiro(a), deverá ser realizado o acompanhamento e avaliação da ferida como também, a evolução em prontuário de toda assistência realizada;

Importante! Deve ser considerado o grau de conhecimento do usuário, familiar e/ou cuidador sobre o diagnóstico, a importância da adesão e continuidade do tratamento e os conhecimentos necessários de execução do curativo para garantir a efetividade do tratamento.

- ✓ Fazer recomendações ao usuário, familiar e/ou cuidador (dieta, higiene, vestuário, repouso, hidratação oral e tópica, troca de curativo, cuidado com a cobertura secundária);
- ✓ Fazer encaminhamento para o médico ou demais profissionais da equipe multidisciplinar da Unidade de Saúde, se necessário (por exemplo: infecção, gangrena, ausência de perfusão periférica e pulso em extremidades, desnutrição, risco social, etc);
- ✓ Evoluir em prontuário eletrônico toda a assistência de enfermagem relacionada a(s) ferida(s) em questão;



- ✓ Cabe ao(à) enfermeiro(a) orientar e supervisionar a equipe de enfermagem, assim como realizar a supervisão periódica em sala de curativos.

Para registro do curativo especial, deve-se utilizar o código de procedimento **03.01.10.027-6 - Curativo Especial** (consiste em curativos realizados em feridas complexas, com uso de elementos de cobertura adicionais à gaze como hidrocoloide (placas ou gel), alginatos e enzimas, na presença de exsudação considerável, perda significativa de tecido/necrose, maceração, processo inflamatório relevante ou outras características locais que demandam avaliação mais qualificada e no geral determinam uma cicatrização mais lenta e difícil), somente utilizar este código de curativo se for efetivamente realizada a troca de curativo pelo profissional.

Bota de Unna

- ✓ O cirurgião vascular é o profissional responsável pela indicação de Bota de Unna;
- ✓ O usuário procura a UBSF com a prescrição do especialista em mãos e apresenta ao(à) enfermeiro(a) em consulta, que deve: avaliar, mensurar, classificar a ferida e solicitar o material por meio do link do link: bit.ly/curativosille, atendendo ao Programa de Curativos Especiais;
- ✓ A Bota de Unna tem como referência técnica Enfermeiro(a) Estomaterapeuta, atualmente com lotação na Policlínica Boa Vista. Caso o(a) enfermeiro(a) não possua capacitação para colocar Bota de Unna, deve ser agendando diretamente com o(a) Enfermeiro(a) Estomaterapeuta na Policlínica Boa Vista, pelo telefone: 3417-1313, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O(a) enfermeiro(a) assistente deve agendar a capacitação, levar a cobertura especial já solicitada e comunicar o usuário do dia e horário do agendamento na Policlínica.

De acordo com o Memorando SEI nº 8588044/2021, apenas o(a) profissional enfermeiro(a) capacitado(a) pelo especialista estomaterapeuta pode realizar o curativo de Bota de Unna.

LEMBRETE

O tratamento de feridas deve ser centrado no paciente, interdisciplinar, baseado em evidências e holístico!

“TRATE TODO PACIENTE, NÃO APENAS A LESÃO NO PACIENTE” Dr. Gary Sibbald

RECEBIMENTO E DISPENSAÇÃO DAS COBERTURAS ESPECIAIS

O prazo de resposta à solicitação é de 72h com evolução em prontuário eletrônico, se aprovado o pedido de material é encaminhado ao CAME, se não for aprovado é realizada a devolutiva para o(a) Enfermeiro(a) da UBSF de referência por meio do e-mail informado no momento da solicitação do curativo. Após a aprovação do material, o servidor do CAME tem 48 horas para separar as coberturas especiais para retirada do material pela UBSF (profissional delegado pela Coordenação).

Caso seja necessário, o responsável pelo Programa de Curativos Especiais tem autonomia para alterar a cobertura especial.

REGISTRO DO RECEBIMENTO DO CURATIVO ESPECIAL

Após recebimento da cobertura na Unidade de Saúde, o(a) enfermeiro(a) prescritor deverá realizar dois registros no prontuário eletrônico:

- ✓ Registro de recebimento de pedidos de material – Entrada Estoque;
- ✓ Atendimento no Dispensário.

Ambos no Ambiente de Trabalho: DISPENSÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA (segue abaixo o



passo a passo). Importante que o registro de cada cobertura especial seja realizado corretamente no prontuário eletrônico SIG-SaúdeTech, pois é fundamental para o respaldo dos atendimentos prestados aos usuários e para o controle de estoque de cada UBSF.

REGISTRO DE RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE MATERIAL – ENTRADA ESTOQUE

Acessar Ambiente de Trabalho: DISPENSÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA

- ✓ Clicar: materiais (lado esquerdo da tela) → receber materiais → registro de recebimento de pedidos de material – entrada estoque: requisição nr.: (inserir o número de requisição do documento físico grade de requisição - consulta) → clicar em código de entrega: (selecionar o código de entrega da ordem de entrega registrada para requisição em situação: aguardando recebimento) → registrar recebimento - baixar → confirmar? ok
- ✓ Mensagem: Recebimento da requisição concluído com sucesso!

ATENDIMENTO NO DISPENSÁRIO

Acessar Ambiente de Trabalho: DISPENSÁRIO DA FARMÁCIA BÁSICA

- ✓ Clicar: atendimento (lado esquerdo da tela) → usuário sus: (inserir a matrícula do usuário) → iniciar atendimento → atendimento no dispensário: selecionar receita simples → dados para dispensação de receita simples: profissional desta unidade (localizar e selecionar o profissional) → iniciar dispensação simples → dispensação direta: material: (informe código ou pesquise ao lado - selecionar o item correto) → confirmar → quantidade entrega: (atentar a unidade de medida; frasco/grama/peça/unidade/rolo) → lote (selecionar o lote com validade do item) → entregar
- ✓ Mensagem: a dispensação do material concluída com sucesso!
- ✓ Abrirá a página com o item registrado → checar as informações e se corretas → clicar em concluir dispensação (em baixo no lado esquerdo da tela) → concluir/novo atendimento (em cima no lado direito da tela).

AVALIAÇÕES SUBSEQUENTES DA FERIDA

- ✓ A reavaliação da evolução da ferida realizada pelo(a) enfermeiro(a) deve ocorrer no mínimo uma vez ao mês;
- ✓ Usuários acamados em domicílio/Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) deverão ter sua reavaliação mensal realizada pelo(a) enfermeiro(a) em visita de monitoramento da lesão e uso da cobertura especial;
- ✓ Deve haver pelo menos uma evolução mensal do(a) enfermeiro(a) assistente em prontuário eletrônico, SIG-SaúdeTech;
- ✓ Avaliar a evolução da ferida e a adesão do usuário ao tratamento proposto, é neste momento que o(a) enfermeiro(a) deve avaliar a indicação de troca de cobertura especial de acordo com as características atuais da ferida e, também os critérios de desligamento/alta do programa;
- ✓ A solicitação da cobertura especial deve ser realizada mensalmente pelo enfermeiro como pedido de materiais mensais dos usuários cadastrados por meio do link: bit.ly/curativosille.

CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO/ALTA DO PROGRAMA

- ✓ Cura (epitelização completa da ferida), orientação de reavaliação do enfermeiro assistente: 1º retorno em 15 dias e 2º retorno em 30 dias;
- ✓ Abandono do tratamento: descumprimento dos critérios de inclusão, sem seguimento após três tentativas de contato;

- ✓ Não seguir corretamente as orientações dadas pelos profissionais da equipe de saúde ou não concordar com elas;
- ✓ Mudança de endereço: referenciar para outra Unidade de Saúde que realizará um novo cadastro;
- ✓ Óbito;
- ✓ A pedido: quando o desligamento é solicitado pelo usuário ou outro profissional de saúde;
- ✓ Falência do tratamento: após 1 ano de tratamento sem evolução (estagnação da ferida). Manter o curativo convencional após este desligamento;
- ✓ O desligamento/alta do programa deve obrigatoriamente ser oficializado pelo enfermeiro como **Alta do Programa** por meio do link: bit.ly/curativosille.

Importante: O desligamento/alta do Programa sempre deve ser registrado em prontuário eletrônico, SIG-SaúdeTech, exceto no caso de óbito.

DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS AO CAME

Todo material especial dispensado ao usuário que não tenha sido utilizado, deverá ser devolvido ao CAME, com a embalagem íntegra e dentro do prazo de validade. Preencher o Formulário de Devolução no GLPI: material, quantidade e motivo da devolução.

KIT BÁSICO DA COBERTURA ESPECIAL PARA USO INTERNO DA UBSF

O(a) enfermeiro(a) solicita mensalmente, por meio do link: bit.ly/curativosille, um Kit Básico por equipe ESF para utilizar na sala de curativos nas suas primeiras avaliações de feridas ou para aqueles usuários que não se enquadram nos critérios de inclusão do Programa de Curativo.

Kit básico da cobertura especial, conforme disponibilidade no CAME:

- ✓ 1 limpador de feridas (PHMB);
- ✓ 1 hidrogel com alginato;
- ✓ 5 gazes antiaderente;
- ✓ 1 Ácido Graxos Essenciais (AGE).

ATENÇÃO! Ferida tumoral: é contra indicado o uso de AGE em feridas com suspeita de malignidade/ferida tumoral, pois ativa o processo de Angiogênese.

Considerando o descritivo do Limpador de Feridas (PHMB):

Ação/característica: Solução de limpeza com ação surfactante para remoção de necroses residuais, debris celular, camadas incrustadas de fibrina, biofilme, resíduos de bandagens, curativos, géis, etc., promovendo uma descontaminação da ferida, diminuindo o tempo de cicatrização, além de auxiliar na redução dos odores da ferida;

Aplicação: Umidificar gaze com o produto e mantê-la em contato com a ferida por um período de 10 à 15 minutos. Após a abertura do frasco, identificar com a data de abertura, pois, poderá ser utilizado em 30 dias e/ou conforme a orientação do fabricante. O frasco somente manterá a esperada validade se for usado mantendo os devidos cuidados de manipulação: fechamento imediato após o uso, proteção da tampa superior de contaminação e/ou contato direto. Caso ocorra contato direto com alguma ferida, desprezar a solução;

Contra-indicação: Reações alérgicas ou de sensibilidade aos componentes da solução. Não deve ser utilizado no primeiro trimestre da gravidez; não deve ser misturado a produtos de limpeza de feridas como sabões, pastas, óleos, enzimas; não deve ser utilizada em combinação com tensoativos aniônicos; não utilize em cartilagem hialina (encontrado por exemplo no anel da traqueia, laringe, brônquios).



Em caso de queixa técnica das coberturas especiais: o enfermeiro deverá preencher o formulário de notificação de queixas técnicas para produtos médico-hospitalares e equipamentos médico-hospitalares, disponível no Processo SEI **0010996666** e enviar para a base SEI do Setor de Compras: **SES.UAF.ACM**.

Observações:

Em caso de dúvidas entrar em contato:

- ✓ E-mail do Programa Municipal de Curativos Especiais: curativosjoinville@gmail.com
- ✓ Telefone do Programa Municipal de Curativos Especiais: (47) 3481-5165
- ✓ E-mail institucional do CAME: came.saude@joinville.sc.gov.br
- ✓ Telefones CAME: (47) 3434-0139

Importante ressaltar que toda tramitação de dados de usuários **DEVE** estar em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados** (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Referências

1. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília – DF: 2008.
2. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986**. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, dá outras providências. Brasília – DF: 1986.
3. Comitê Internacional de Classificação da Organização Mundial de Associações Nacionais, Academias e Associações Acadêmicas de Clínicos Gerais/ Médicos de Família (WONCA). Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Florianópolis – SC: 2009.
4. Prefeitura de Joinville. Secretaria da Saúde. Gerência de Unidade de Atenção Básica. Núcleo de Apoio Técnico. **Protocolo de Assistência no Tratamento de Feridas**. Joinville – SC: 2015.
5. SMANIOTTO, P.H.S.; GALLI, R.; CARVALHO, V.F.; FERREIRA, M.C. Tratamento clínico das feridas – curativos. Rev. Med. 2010; 89 (3/4): 137-41. São Paulo – SP: 2010.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2022 Fernanda Cristina Spiller Michelle Stringhini	2022 Flávia Favaretto Kerolin Daniele Schatzmann Maristela Mello de Aguiar	2022 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível pelo Endereço Eletrônico

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 22.0.413807-4

Alteração após Revisão

Nº	Data	Responsável	Alteração
01			

